

План питания: коксартроз 4 ст., восстановление ЖКТ

Мужчина 53 года · без сахара, без глютена, без молочки · 2 приёма пищи, без перекусов · еда мягкая, овощи ошпаренные

ПРИОРИТЕТ КАРДИОЛОГА. На ЭКГ резко выраженная нерегулярность ритма (RR 592-1334 мс), предсердная экстрасистолия, брадисистолия 56. Это требует холтера и очного заключения кардиолога. До получения заключения: никаких нагрузочных проб, никаких провокационных вмешательств, никаких разгрузочных дней, никакого голодания и никаких интервальных схем. Питание по этому плану — обычная мягкая еда, оно не является нагрузкой. Любые физические нагрузки на подготовку к операции назначает кардиолог, не нутрициолог.

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Главная мишень плана — внутрибрюшное давление. Переполненный желудок и вздутая кишка поднимают давление в животе, а оно бьёт сразу по трём направлениям.
2. Вверх — на диафрагму: при несостоятельной кардии содержимое выдавливается в пищевод. Вперёд — живот выпирает, таз разворачивается, и нагрузка на больной сустав растёт. Внутрь — сдавливаются сосуды и лимфа, отток ухудшается.
3. Поэтому объём еды режем. Из двух ошибок — недоесть и переесть — всегда выбираем недоесть. В 53 года это не аскеза, а условие, при котором ЖКТ вообще способен работать.
4. Подсчёта белка нет и не будет. Считать граммы можно, когда ЖКТ их пропускает. Здесь он не пропускает — и норма превращается в гниение в кишечнике.
5. Сниженная кислотность означает, что белок не расщепляется до конца. Непереваренный белок идёт дальше и даёт газ, вздутие и нагрузку на печень. Это и есть шило на мыло.
6. Застой желчи означает, что жир не эмульгируется. Избыток жира за один приём даст тяжесть и стул с жиром, а не пользу. Поэтому жир умеренный, но в каждом приёме.
7. Нагруженная поджелудочная не вывозит большой объём. Поэтому объём режем, а качество поднимаем: мягкая текстура, тёплое, протёртое, ничего твёрдого и жареного.
8. Два приёма в день — основной режим. Семичасовая пауза даёт мигрирующему моторному комплексу вычистить тонкую кишку. Перекус обнуляет этот процесс полностью.
9. Овощи ошпаренные, отварные, паровые или печёные. Сырая клетчатка при застойной гастродуоденопатии травмирует и бродит. Сырого в плане нет вообще, включая зелень.
10. Продукты природного происхождения в приоритете: рынок, ферма, дикая рыба, деревенские яйца. Промышленная курица и продукты со сложным составом уходят вниз списка.
11. Слизистые восстанавливаются параллельно с очисткой кишечника — это два процесса, которые идут вместе. Отдельные разделы 8 и 9 расписывают оба.
12. Хряща при 4 ст. нет и он не восстановится. Мышца вокруг сустава — единственный оставшийся амортизатор, и она держится не граммами белка, а его усвоением.
13. Отказ от подсчёта переносит контроль с весов на анализы: альбумин, общий белок и копрограмма. Копрограмма прямо покажет, что именно не переваривается.
14. План вторичен по отношению к заключению кардиолога по холтеру — см. красную рамку выше.

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ ГРАММОВ И ЧТО СТОИТ ВМЕСТО НИХ. Расчётные нормы белка исходят из того, что пищеварение работает. При сниженной кислотности, застое желчи и перегруженной поджелудочной норма не усваивается — она бродит. Поэтому граммовка убрана.

Но вслепую мы тоже не идём. Контроль просто переехал с кухонных весов на анализы: альбумин и общий белок покажут, хватает ли белка организму по факту, а копрограмма покажет, что именно не переваривается — жир, мышечные волокна или крахмал. Сдавать раз в 6-8 недель.

Риск, который надо назвать вслух: при коксартрозе 4 ст. мышца — единственный оставшийся амортизатор, а креатинин 63 при норме от 62 уже указывает на её дефицит. Если альбумин пойдёт вниз или общий белок упадёт с нынешних 80,9 — объём белка придётся возвращать, параллельно поднимая пищеварение. Это не повод считать граммы сейчас, это повод сдать копрограмму и смотреть на факт, а не на теорию.

2. РЕЖИМ — два приёма в день, без перекусов

Режим	Когда так едим	Что происходит с ЖКТ
2 приёма 10:00 и 17:00 ОСНОВНОЙ	Обычный день. Так живём большую часть времени	Пауза 7 часов. Кишечник успевает себя вычистить, желудок успевает опорожниться, слизистая получает время на восстановление
3 приёма 10:00 · 13:30 · 17:00	Если между приёмами реально голодно, слабость или падает сахар. Третий приём — лёгкий: протёртый суп и немного белка	Пауза 3,5 часа. Разгрузка слабее, но приемлемо. Третий приём делаем самым лёгким
1 приём 14:00	Только эпизодически, если совсем нет аппетита или тяжело. Один день, не подряд	Максимальная разгрузка. Не режим — разовая мера, когда организм сам просит паузу

Ужин не позже 17:00–18:00 и не позже чем за 3 часа до сна — это жёстко, при недостаточности кардии еда на ночь идёт обратно в пищевод. Между приёмами только тёплая вода и травяной настой. Ничего съедобного, включая «просто орешек» и «просто чай с чем-то».

3. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИЗМ — ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВСЕГО ПЛАНА. Из двух ошибок — недоесть и переесть — всегда выбираем недоесть. Недоеденное спокойно добирается в следующий приём, ничего не теряется. Перееденное давит на диафрагму, толкает еду обратно в пищевод, разворачивает таз и добавляет нагрузки на больной сустав — и стоит в кишке часами. Желудок, заполненный на три четверти, работает. Полный доверху — не работает.

Замкнутый круг, который мы разрываем

Звено	Что происходит	К чему это приводит
1. Объём	Большая порция плюс газ от брожения — объём в животе растёт	Внутрибрюшное давление поднимается. Дальше оно давит во все стороны сразу
2. Вверх — на диафрагму	Давление снизу подпирает диафрагму и желудок	При несостоятельной кардии содержимое выдавливается в пищевод: изжога, отрыжка, кислое в горле, особенно лёжа
3. Вперёд — на брюшную стенку	Живот выпирает, центр тяжести уходит вперёд	Таз наклоняется вперёд, поясница прогибается сильнее, меняется угол в тазобедренном суставе — и нагрузка на больной сустав растёт. Это то, что мы снимаем
4. Внутрь — на сосуды и лимфу	Сдавливаются вены и лимфатические сосуды брюшной полости	Отток ухудшается: застой, отёчность, тяжесть. Лимфа не двигается
5. На саму кишку	Растянутая петля сокращается хуже — как перерастянутая резинка	Еда стоит дольше, брожение усиливается, газа становится больше
6. Круг замкнулся	Больше газа → выше давление → хуже моторика → ещё больше газа	Вздутие само себя поддерживает. Само оно не пройдёт — круг надо разорвать снаружи

Чем именно разрываем

Чем разрываем круг	Как это работает
Меньше объём за один раз	Прямое снижение давления. Самый быстрый по эффекту рычаг из всех
Мягкая текстура: ошпаренное, разваренное, протёртое	Желудку не нужно долго перемалывать — он опорожняется быстрее и меньше растянут
Паузы без перекусов	В пустой кишке включается моторный комплекс, который выметает остатки и газ
Псиллиум по нарастающей	Формирует стул и убирает застой содержимого — меньше субстрата для брожения
Ничего сырого и газообразующего	Убирает сам источник газа: бобовые, капусту, лук, грубую клетчатку
Ужин за 3 часа до сна, час не ложиться после еды	Горизонтальное положение при полном желудке — худшее сочетание при кардии

4. ЧТО МЫ ХОТИМ УСВОИТЬ И ЧТО ЭТОМУ МЕШАЕТ

Что усваиваем	Куда это идёт	Что мешает	Что делаем в плане
Белок	Мышца вокруг сустава, слизистая, заживление после операции	Низкая кислотность, непрожёванный кусок, большой объём за раз	Суфле, тефтели, паровое. Жевать медленно, 20 минут на приём. Объём меньше
Жиры	Витамины А, D, Е, К, гормоны, оболочки клеток	Застой желчи, много жира за один раз, жареное	1 ст. л. масла в каждый приём — не больше и не меньше. Без жира желчь не выходит вообще
Углеводы	Энергия — чтобы белок шёл на мышцу, а не сгорал как топливо	Неразваренный крахмал, брожение, объём	Крупы развариваем в полтора раза дольше. Порция небольшая, только в первый приём
Витамин А	Эпителий, слизистая желудка и кишки — то, что мы восстанавливаем	Отсутствие жира в том же приёме	Тыква, морковь, батат и желток — всегда вместе с маслом, иначе бесполезно
Витамин D	Мышца, кость, иммунитет перед операцией	Нет жира в приёме, собственный дефицит	D3 с тем приёмом, где есть масло. Точная доза — после 25(OH)D
Цинк	Слизистая, заживление, собственные ферменты пищеварения	Псиллиум в один приём с ним, фитаты	Цинк-карнозин, разнос с псиллиумом 2 часа
Магний	Мышца, спазм желчных путей, сердечный ритм	Форма оксида, вздутие	Только цитрат или глицинат, вечером
Железо	MCV 87,4 на нижнем краю — запас уже подтачивается	Низкая кислотность: без кислоты железо не переходит в усвояемую форму	Витамин С в тот же приём. Сдать ферритин — перед операцией это критично
Кальций	Кость, к которой будут крепить протез	Молочки в рационе нет — главный источник выпал	Молотый кунжут и миндаль, обогащённое растительное молоко, K2 для направления кальция в кость

Ничто из этого не восстановит хрящ — при 4 ст. его нет и не будет. Но всё это идёт на мышцу вокруг сустава, на слизистую, на снижение воспаления и на подготовку к операции. А снижение внутрибрюшного давления снимает с сустава ту часть механической нагрузки, которую создаёт сам вздутый живот. Две разные задачи — и обе решаются одним и тем же: меньше объём, мягче текстура, длиннее паузы.

5. СКОЛЬКО ЕСТЬ — граммов нет, есть сигналы тела

Сигнал	Что это значит	Что делать
Встал из-за стола с мыслью «мог бы съесть ещё немного»	Это правильный объём. Именно так и надо	Ничего, всё верно
Наелся, приятная сытость, тяжести нет	Верхняя граница нормы. Можно так, но лучше чуть меньше	Оставить как есть
После еды клонит в сон, хочется прилечь	Переел. Организм бросил кровь на пищеварение	Следующий приём — минус треть порции
Тяжесть, распирание, отрыжка сразу после еды	Переел или еда была слишком твёрдой и жирной	Минус треть объёма, всё протереть, жир уменьшить
Вздутие через 1,5-2 часа после еды	Не переварилось. Либо объём, либо текстура, либо сырое проскочило	Проверить: всё ли было ошпарено и разварено. Порцию уменьшить
Изжога, кислое в горле, особенно лёжа	Объём порции превысил то, что желудок может удержать	Порция меньше, после еды час не ложиться, изголовье выше на 10-15 см
Голод раньше, чем через 4 часа	Приём был слишком лёгким или в нём не хватило белка и жира	Добавить белок и ложку масла, а не увеличивать крупу

Есть медленно, не меньше 20 минут на приём, тщательно пережёвывая. При сниженной кислотности жевание — это первая ступень пищеварения, и она единственная, которой можно управлять сознательно. Проглоченный кусок непрожёванного мяса желудок с низкой кислотностью не расщепит.

6. ТАРЕЛКА — ориентир, а не измерение

Часть тарелки	Что кладём	Как готовим
Половина — овощи	Кабачок, тыква, морковь, шпинат, стручковая фасоль, батат, свёкла	Ошпарить 2–3 минуты кипятком, отварить, на пару или запечь. Сырого нет
Четверть — белок	Яйца, рыба, индейка, кролик, фермерская птица. Порция с ладонь без пальцев	На пару, отварить, запечь, суфле или тефтели. Ничего жареного и жёсткого
Четверть — крупа	Гречка, рис, пшено, киноа, овсянка без глютена, батат, картофель	Разварить до мягкости, чуть больше воды и времени, чем обычно. Тёплой, не горячей
Сверху — жир	Оливковое масло, топлёное масло гхи. 1 столовая ложка, не больше	Добавлять в готовое, не жарить. Жир нужен: без него не выйдет желчь

Тарелка — это ориентир, а не измерение. Никаких весов. Пропорции глазом, объём — по сигналам из раздела 5. Если крупа не помещается или после неё тяжело, крупу убираем совсем и оставляем белок с овощами.

7. КАК ГОТОВИТЬ — мягко, тепло, без сырого

Что	Как именно	Зачем
Ошпаривание овощей	Нарезать, залить крутым кипятком, поддержать 2–3 минуты, слить воду	Снимает грубость клетчатки, но сохраняет больше, чем варка. Базовый приём
Отваривание	До полной мягкости, чтобы разминалось вилкой. Не «аль денте»	Недоваренный овощ при гастродуоденопатии бродит и даёт газ
На пару	10–15 минут, пока не станет мягким	Самый щадящий способ, максимум сохранности
Запекание	В фольге или рукаве, без корочки, без масла сверху	Мягкая текстура без жарки. Корочка — это то же жареное
Протирание и суфле	Готовое пробить блендером. Супы-пюре, рыбные и мясные суфле, тефтели	Механическая работа сделана до желудка. При сниженной кислотности это ключевое
Разваривание круп	Воды в полтора раза больше обычного, времени в полтора раза дольше	Разваренный крахмал усваивается легче и не бродит
Температура еды	Тёплая. Не горячая и не из холодильника	Холодное спазмирует желчные пути, горячее травмирует слизистую
Зелень	Ошпарить 30–60 секунд перед подачей	Сырая зелень — та же сырая клетчатка. В этом плане сырого нет
Мясо и рыба	Только мягкие способы. Если жёсткое — в фарш, в суфле, в тефтели	Жёсткие волокна желудок с низкой кислотностью не осилит

8. ПРОТОКОЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛИЗИСТЫХ

Продукты, которые работают на слизистую. Должны быть в рационе постоянно, а не курсом

Продукт	Как употреблять	Что даёт слизистой
Семя льна — кисель	1 ст. л. на 300 мл, довести до кипения, настоять, пить тёплым с приёмом пищи	Обволакивает, механически защищает стенку желудка и кишки
Овсянка без глютена — кисель или разваренная	Тёплой, с приёмом пищи	Бета-глюканы, мягкая слизь, питание для стенки
Рис разваренный и рисовый отвар	Тёплым, отвар можно пить отдельно	Обволакивает, успокаивает раздражённую слизистую
Тыква печёная	Регулярно, почти каждый день	Бета-каротин → витамин А, главный витамин эпителия
Морковь отварная с маслом	Обязательно вместе с жиром, иначе каротин не усвоится	Бета-каротин, восстановление покровного слоя
Батат печёный	Регулярно, вместо картофеля	Бета-каротин плюс мягкая клетчатка, не раздражает

Продукт	Как употреблять	Что даёт слизистой
Яичный желток	Каждый день, всмятку или на пару	Готовый витамин А и холин — строительный материал стенки
Кабачок печёный или тушёный	Каждый день, база рациона	Самая мягкая клетчатка, не травмирует и не бродит
Настой ромашки	Тёплым, после еды	Противовоспалительное действие на слизистую
Корень алтея — настой	Тёплым, отдельно от еды на 30 минут	Обволакивающее. Работает мягче солодки и без её рисков
Облепиховое масло	1 ч. л. с приёмом пищи	Каротиноиды и витамин Е — прицельно на заживление эпителия
Проростки брокколи, слегка ошпаренные	1–2 раза в неделю, небольшая порция	Сульфорафан — поддержка слизистой желудка
Тыквенные семечки молотые	1 ч. л. в готовое блюдо. Обязательно молотые, не целые	Цинк — без него слизистая не восстанавливается
Рыба и яйца	Каждый день, мягкими способами	Цинк, витамин А и белок — материал, из которого строится эпителий

Чего в этом протоколе нет — и почему именно у этого клиента

Чего в протоколе слизистых НЕТ	Почему именно у этого клиента
Костный бульон	Классика протоколов по слизистым, но здесь исключён: концентрат пуринов при мочевой кислоте 418 из потолка 416,5
Желатин, холодец, коллаген в объёме	То же самое — пуриновая нагрузка. И хрящ при 4 ст. этим не восстанавливается
Солодка, сироп солодки	Поднимает давление и вымывает калий. При предсердной экстрасистолии и гипертрофии МЖП 12 мм это прямой риск. Заменена корнем алтея
Свежий капустный сок	Классический витамин U, но сырой и газообразующий. Только если хорошо переносится, 50–100 мл, и не в первые две недели
Бетаин HCl и ферментные препараты	Не назначаю. Сниженная кислотность пока предположение, её надо подтвердить гастропанелью. Кислота вслепую при застойной гастродуоденопатии может усилить повреждение. Это решение гастроэнтеролога, не нутрициолога
Желчегонные: артишок, расторопша, бессмертник, кукурузные рыльца	Не назначаю до УЗИ органов брюшной полости. При камнях в желчном пузыре желчегонные опасны — они могут сдвинуть камень. Сначала УЗИ, потом разговор
Острые специи, имбирь в объёме, чеснок	Раздражают слизистую, которую мы восстанавливаем. Работаем мягкими: укроп, фенхель, тмин, ромашка

9. МЯГКАЯ ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА — псиллиум по нарастающей

Этап	Псиллиум	Как принимать
Неделя 1	3 г — примерно 1 ч. л.	Один раз в день, вместе с приёмом пищи. Размешать в 250 мл тёплой воды, выпить сразу, сверху ещё 200 мл воды
Неделя 2	5 г — с горкой	Так же, один раз в день с приёмом пищи
Неделя 3 и далее	7–10 г — 1 ст. л.	Можно разделить на два приёма пищи, по половине дозы в каждый
Если усилилось вздутие	Шаг назад	Вернуться к предыдущей дозе на неделю, потом снова пробовать поднять. Не бросать и не терпеть
Вода	Обязательное условие	Не меньше 30 мл на кг веса в сутки. Без воды псиллиум даёт обратный эффект — запор
Разнос с добавками	2 часа	Псиллиум сорбирует всё подряд, включая цинк, D3 и K2. В один приём с ними не пить

Признак, что очистка работает: стул мягкий, оформленный, каждый день, без натуживания и без ощущения неполного опорожнения. Резких «чисток», клизм, слабительных трав и тюбажей в этом плане нет — при кальцинозе клапанов, аритмии и возможных камнях в желчном это лишний риск. Работаем медленно и мягко.

10. ВАРИАНТ А — готовая таблица на 14 дней

День	ПРИЁМ 1 · 10:00	ПРИЁМ 2 · 17:00	ЕСЛИ НУЖЕН ТРЕТИЙ · 13:30
День 1	Омлет на пару из 2 яиц; тыква запечённая; гречка разваренная	Треска на пару; рагу из кабачка с морковью	Крем-суп из кабачка с ошпаренной зеленью
День 2	Яйца всмятку; батат запечённый; шпинат ошпаренный	Индейка тушёная до мягкости; тыква с морковью запечённые	Крем-суп из тыквы
День 3	Суфле из трески на пару; рис разваренный; морковь отварная	Кролик тушёный; кабачок и стручковая фасоль на пару	Кисель льняной; 4 перепелиных яйца всмятку
День 4	Омлет на пару с ошпаренным шпинатом; пшено разваренное	Судак на пару; рагу из тыквы, кабачка и моркови	Крем-суп из моркови и батата
День 5	Яйца пашот; тыква запечённая; гречка разваренная	Индейка на пару; шпинат и кабачок тушёные	Крем-суп из кабачка и стручковой фасоли
День 6	Суфле из минтая на пару; батат печёный	Горбуша запечённая в фольге; морковь и кабачок тушёные	Овсяный кисель без глютена; 2 яйца всмятку
День 7	Омлет на пару из 2 яиц; морковь отварная; рис разваренный	Кролик тушёный; тыква запечённая, стручковая фасоль на пару	Крем-суп из тыквы и моркови
День 8	Яйца всмятку; кабачок печёный; гречка разваренная	Хек на пару; рагу из шпината и кабачка	Крем-суп из батата
День 9	Суфле из индейки на пару; батат печёный	Треска запечённая; морковь и стручковая фасоль на пару	Кисель льняной; яйцо всмятку
День 10	Омлет на пару со шпинатом; пшено разваренное	Форель запечённая; кабачок и тыква тушёные	Крем-суп из кабачка и моркови
День 11	Яйца пашот; тыква с морковью запечённые; рис разваренный	Индейка тушёная; шпинат ошпаренный, стручковая фасоль на пару	Крем-суп из тыквы с зеленью
День 12	Суфле из судака на пару; гречка разваренная	Кролик тушёный; кабачок, морковь и батат запечённые	Овсяный кисель без глютена; 4 перепелиных яйца
День 13	Омлет на пару; морковь отварная; батат печёный	Горбуша на пару; рагу из кабачка и стручковой фасоли	Крем-суп из моркови
День 14	Яйца всмятку; тыква запечённая; рис разваренный	Телятина, тушённая до полной мягкости; шпинат и кабачок тушёные	Крем-суп из тыквы и кабачка

- Граммовки нет намеренно. Объём — по сигналам из раздела 5: встал с мыслью «мог бы ещё немного» — значит верно.
- К каждому приёму 1 ст. л. оливкового масла или гхи. Жир обязателен: без него не выходит желчь и не усваивается каротин из тыквы и моркови.
- Третий приём — только если реально голодно. По умолчанию его нет.
- После каждого приёма тёплый настой: ромашка, фенхель, укроп, тмин. Не мята.
- Дни можно менять местами целиком. Приёмы внутри дня местами не менять — крупа стоит в первом приёме не случайно.
- Жирная рыба (горбуша, форель) стоит 3 раза за 14 дней — это удерживает омега-3 заметно ниже лимита 1 г ЭПК+ДГК в сутки.
- Телятина один раз за 14 дней. Красное мясо чаще не нужно: пурины при мочевой кислоте 418.

11. ВАРИАНТ Б — без таблицы. Собери тарелку сам

Слот	Выбирай отсюда — сверху самое природное
Белок — яйца	Деревенские куриные яйца с рынка · перепелиные яйца · магазинные яйца. Каждый день, это самый низкопуриновый и самый усвояемый белок
Белок — рыба	Дикая белая рыба: треска, судак, минтай, хек, пикша · горбуша и форель не чаще 2 раз в неделю
Белок — мясо	Кролик · фермерская индейка · домашняя птица с рынка · телятина травяного откорма не чаще раза в неделю. Промышленная куриная грудка — в самом низу списка
Крупа	Гречка · рис · пшено · киноа · овсянка «без глютена» · батат · картофель. Всё разваренное
Овощи	Кабачок и цукини · тыква · морковь · шпинат · стручковая фасоль · батат · свёкла отварная · брокколи небольшой порцией. Всё ошпаренное, варёное, паровое или печёное
Жир	Оливковое масло холодного отжима · гхи · облепиховое масло 1 ч. л. · молотые тыквенные семечки
Питьё	Тёплая вода · ромашка · фенхель · укроп · тмин · корень алтея · рисовый отвар · льняной кисель · цикорий
Ягоды — по переносимости	Черника, брусника, клюква — до горсти, только вместе с приёмом пищи, не каждый день и не натошак

12. ЗАМЕНЫ — чем закрыть сахар, глютен и молочку

САХАР

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Сахар, мёд, сиропы, финики, сухофрукты, соки	Стевия — и всё. Сушёное и соки не заменяются, они просто уходят: фруктоза поднимает мочевую кислоту напрямую	ВкусВилл, Перекрёсток
Эритрит, ксилит, сорбит и прочие сахарные спирты	НЕ используем. Дают вздутие, а по эритриту есть сигнал по сердечно-сосудистым событиям — при кальцинозе клапанов это лишнее	—
Конфеты, шоколад, десерты	Печёная тыква со стевией и корицей · ягоды горстью с приёмом пищи. Шоколад не заменяем: он и сахар, и расслабляет сфинктер пищевода	рынок, ВкусВилл
Газировка, сладкие напитки	Тёплая вода, ромашка, фенхель, рисовый отвар, льняной кисель, цикорий	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл

ГЛЮТЕН

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Пшеница, рожь, ячмень, белая мука, манка, булгур, кускус	Гречка, рис, пшено, киноа, кукурузная крупа, овсянка «без глютена». Всё разваренное до мягкости	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл, рынок
Хлеб	Гречневые и рисовые хлебцы — но размачивать в супе, сухое царапает слизистую. Проще обойтись совсем	ВкусВилл, Перекрёсток
Макаронны	Паста из гречки или риса, разваренная	Перекрёсток, ВкусВилл
Мука для загущения	Рисовая, гречневая, кукурузная мука, картофельный крахмал — в супы и суфле	ВкусВилл, Перекрёсток

МОЛОЧКА

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Молоко	Кокосовое или рисовое без сахара — тёплым, в кашу и суфле	ВкусВилл, Перекрёсток
Сливки	Кокосовые сливки, немного — это жир, а жир при застое желчи дозируем	ВкусВилл
Творог, йогурт	Кокосовый йогурт без сахара, комнатной температуры	ВкусВилл
Сыр	Проще обойтись: это жир и соль. Изредка ореховый	ВкусВилл
Сливочное масло	Гхи — казеина и лактозы в нём нет, и оно хорошо переносится при раздражённой слизистой. Наравне с оливковым маслом	Перекрёсток, ВкусВилл, рынок

13. ИСКЛЮЧЕНИЯ — и причина по каждому пункту

Что исключаем	Причина — конкретно по этому случаю
Всё сырое: салаты, свежие овощи, свежая зелень, фрукты кусками	Сырая клетчатка при застойной гастродуоденопатии травмирует стенку и бродит. Ошпаривания 2–3 минуты достаточно, чтобы это снять
Жареное, фритюр, корочка, панировка	Замедляет опорожнение желудка и провоцирует заброс. Плюс прямая нагрузка на желчный
Твёрдое, жёсткое, волокнистое мясо, орехи целиком, сухие хлебцы всухую	Механическая травма слизистой и работа, которую желудок с низкой кислотностью не выполнит
Алкоголь полностью	Мочевая кислота 418 из потолка 416,5. Плюс провокация предсердной экстрасистолии, плюс прямое повреждение слизистой
Сахар, мёд, сиропы, сухофрукты, соки, сладкие напитки	Фруктоза — единственный углевод, поднимающий мочевую кислоту напрямую. Плюс глюкоза 6,78
Костные бульоны, холодец, желатин в объёме	Пуриновая нагрузка. Классические «схемы для суставов» на бульонах здесь противопоказаны
Субпродукты: печень, почки, сердце, язык	Самая высокая концентрация пуринов, 300+ мг на 100 г
Сардины, анчоусы, сельдь, шпроты, икра	300–500 мг пуринов на 100 г — верхняя группа риска
Красное мясо чаще одного раза в неделю	Пурины плюс кардиометаболический риск при гипертрофии МЖП и кальцинозе клапанов
Омега-3 в капсулах	Дозы от 1 г ЭПК+ДГК повышают риск фибрилляции предсердий. Субстрат уже есть: экстрасистолия, RR 592–1334 мс
Глюкозамина сульфат	Влияет на углеводный обмен. При глюкозе 6,78 не назначается
Магния оксид	Осмотическое действие и раздражение слизистой при застойной гастродуоденопатии
Кофе, включая растворимый и без кофеина	Расслабляет нижний пищеводный сфинктер — прямой заброс при недостаточности кардии. Плюс провокация экстрасистолии
Мята и мятный чай	Расслабляет сфинктер пищевода сильнее, чем кофе
Шоколад и какао	Расслабляет сфинктер плюс сахар — два повода сразу
Томаты, томатная паста, кетчуп	Кислота, прямое раздражение при застойной гастродуоденопатии
Цитрусовые и кислые соки	Кислота, рефлюкс. Витамин С добираем буферной добавкой, а не апельсином
Острое: чили, аджика, хрен, горчица, чеснок	Раздражение слизистой, которую мы восстанавливаем
Газированные напитки	Механически растягивают желудок и выдавливают содержимое в пищевод
Еда позже 18:00 и еда перед сном	Объём плюс горизонтальное положение — два главных триггера при недостаточности кардии
Перекусы между приёмами	Любая еда в паузе останавливает мигрирующий моторный комплекс — механизм, которым кишечник себя чистит. Без пауз вздутие не уйдёт
Бобовые, капуста белокочанная, лук репчатый, грибы, кукуруза	Газообразование при хронической склонности к вздутию

Что исключаем	Причина — конкретно по этому случаю
Пшеница, рожь, ячмень, белая и ржаная мука	По условию: питание без глютена
Все молочные продукты, кроме гхи	По условию: питание без молочки. Отмечу: молочка снижает мочевую кислоту, и это компенсируем водой, псиллиумом и витамином С
Бульонные кубики, дрожжевой экстракт, готовые соусы, продукты со сложным составом	Пурины из дрожжей, натрий и добавки. Работаем на продуктах природного происхождения
Клизмы, тюбажи, слабительные травы, «чистки» печени	При кальцинозе клапанов, аритмии и невыявленном состоянии желчного это риск без доказанной пользы

14. ПОКУПКИ — рынок в приоритете

Категория	Что берём	Рынок	ВкусВилл	Перекрёсток	Пятёрочка
Яйца	Деревенские куриные, перепелиные	лучше всего	есть	есть	есть
Рыба	Треска, судак, минтай, хек — дикая, не садковая	лучше всего	есть	есть	есть
Рыба жирная	Горбуша, форель — 2 раза в неделю	есть	есть	есть	есть
Мясо	Кролик, фермерская индейка, домашняя птица	лучше всего	есть	есть	не всегда
Мясо	Телятина — раз в неделю, не чаще	лучше всего	есть	есть	есть
Овощи	Кабачок, тыква, морковь, свёкла, батат	лучше всего	есть	есть	есть
Овощи	Шпинат, стручковая фасоль — можно замороженные	сезонно	есть	есть	есть
Зелень	Укроп, петрушка — ошпаривать перед подачей	лучше всего	есть	есть	есть
Крупы	Гречка, рис, пшено, киноа, кукурузная крупа	есть	есть	есть	есть
Крупы	Овсянка «без глютена»	—	есть	есть	не всегда
Жиры	Оливковое масло, гхи	не всегда	есть	есть	не всегда
Для слизистых	Семя льна, тыквенные семечки, облепиховое масло	есть	есть	не всегда	нет
Травы	Ромашка, фенхель, укроп, тмин, корень алтея	есть	есть	не всегда	нет
Без молочки	Кокосовое и рисовое молоко без сахара, кокосовый йогурт	—	есть	есть	не всегда
Добавки	Псиллиум, цинк-карнозин, глутамин, D3, K2, магний, витамин С, креатин	нет	частично	нет	нет

Рынок в приоритете — там продукт ближе к природному: деревенские яйца, дикая рыба, фермерское мясо, сезонные овощи. ВкусВилл закрывает узкие позиции: безглютеновое, кокосовое, семена и травы. Добавки — только аптека или проверенный поставщик, ни рынок, ни супермаркет для них не годятся.

15. НУТРИЦЕВТИКА — всё только с едой, ничего натошак

Что	Доза	Когда	С чем разносить	Зачем
Цинк-карнозин	75 мг 2 раза в день	С обоими приёмами	Не с псиллиумом — 2 часа	Прицельно на слизистую желудка. Заменяет обычный цинк, не добавляется к нему
L-глутамин	5 г 2 раза в день	С едой, размешать в тёплой воде	Не с псиллиумом — 2 часа	Питание клеток кишечной стенки, основной материал для её восстановления
Псиллиум	Старт 3 г, до 7-10 г за 3 недели	С приёмом пищи, 300 мл воды	Отдельно от ВСЕХ добавок — 2 часа, сорбирует их	Мягкая очистка, стул, глюкоза, мочевая кислота. Схема в разделе 9

Что	Доза	Когда	С чем разносить	Зачем
Витамин D3	2000 ME	С приёмом, где есть жир	Вместе с K2	Мышца, кость, иммунитет перед операцией. Точная доза — после 25(OH)D
Витамин K2 МК-7	90–100 мкг	С D3	Вместе с D3	Кальциноз створок: направляет кальций в кость, а не в клапан
Магний цитрат или глицинат	200 мг элементарного	С вечерним приёмом	Не с цинком — 2 часа	Аритмогенный субстрат, спазм желчных путей, стул. Оксид исключён: гастрит
Витамин С буферный (аскорбат)	500 мг	С дневным приёмом	Можно с цинком	Мягко снижает мочевую кислоту, не кислит желудок в буферной форме
Облепиховое масло	1 ч. л.	С приёмом пищи	—	Каротиноиды и витамин Е прицельно на заживление эпителия
Креатин моногидрат	3 г	С дневным приёмом	—	Мышцы при сниженном объёме еды. При креатинине 63 это важнее, а не менее важно

- Омега-3 в капсулах НЕТ: лимит 1 г ЭПК+ДГК и субстрат ФП. Закрывается рыбой из меню.
- Глюкозамина сульфата НЕТ: преддиабет.
- Магния оксида НЕТ: гастрит и рефлюкс.
- Бетаина HCl и ферментов НЕТ: сниженная кислотность требует подтверждения гастропанелью, а кислота вслепую при гастродуоденопатии может усилить повреждение. Это к гастроэнтерологу.
- Желчегонных НЕТ до УЗИ органов брюшной полости: при камнях они опасны.
- Ничего не принимается натошак — все позиции привязаны к приёму пищи.
- K2 отменяется немедленно, если кардиолог назначит варфарин. Сейчас антикоагулянтов нет, МНО 0,99 — приём K2 допустим.
- Креатин может слегка поднять креатинин в анализе. Это лабораторный артефакт, а не поражение почек. Предупредить врача перед сдачей.
- Начинать не всё сразу: первая неделя — только псиллиум и цинк-карнозин. Остальное добавлять по одной позиции раз в 3–4 дня, чтобы понимать, на что реакция.

16. КАЧЕСТВО САМИХ ДОБАВОК — как читать состав на банке

На что смотрим	Что допустимо	Чего быть НЕ должно
Оболочка капсулы	HPMC — растительная целлюлозная. Или чистый желатин	Акрилатные полимеры: Acrylates Copolymer, Methacrylic Acid Copolymer, Eudragit L / S / RS / RL, Ammonio Methacrylate Copolymer. Это микропластик, долгосрочных исследований безопасности нет
Красители	Их не должно быть вообще. Хорошая добавка не бывает цветной	Диоксид титана E171, Aluminium Lake, E102 тартразин, E104, E122, E133, Red 40 (E129), Red 3 (E127), Yellow 5, Yellow 6, оксиды железа
Наполнители	Микrokристаллическая целлюлоза, крахмал, рисовая мука, диоксид кремния, стеарат магния, пектин, гуммиарабик	Тальк E553, PEG и макрогол E1521, пропиленгликоль E477, повидон PVP E1201, кросповидон, кроскармеллоза натрия, минеральное масло и парафин
Технологические добавки	Чем короче состав, тем лучше. В идеале 2–3 позиции после действующего вещества	Натрия лаурилсульфат E487, силиконы (–siloxane, –silicone, –methicone), парабены E216 и E218, ВНА и ВНТ (E320, E321), полисорбат-80 E433
Подсластители и сахар	Ничего. Добавка не должна быть сладкой	Аспартам, цикламат натрия, ацесульфам калия. И сахар, глюкоза, фруктоза в составе самой капсулы
Дозировка на этикетке	Указано точное количество действующего вещества в одной капсуле	«Комплекс трав», «фирменная смесь», состав без цифр — предсказуемого эффекта не будет

- Полисорбат-80 нарушает кишечный барьер — прямо против того, что мы делаем в разделе 8. Из всего списка для этого клиента он худший.
- Кроскармеллоза и кросповидон раздражают ЖКТ у чувствительных — при застойной гастродуоденопатии это лишнее.
- Сахар и фруктоза в составе капсулы недопустимы даже в микродозах: глюкоза 6,78 и мочевая кислота 418.

- Акрилатная оболочка задумана раскрыться в кишечнике, минуя желудок. При сниженной кислотности и замедленной моторике её поведение непредсказуемо — проще взять НРМС.
- БАДы принимаются месяцами. То, что в составе, накапливается вместе с действующим веществом. Поэтому состав читаем целиком, а не только первую строку.
- Источник критериев — «Эффективная база добавок в практике специалиста», Тамара Кузнецова, из вашего архива на Диске.

17. АНАЛИЗЫ К ДОСДАЧЕ

Анализ	Что он даст и что изменит в плане
Копрограмма	ГЛАВНЫЙ анализ этого плана. Прямо покажет, что не переваривается: нейтральный жир — не хватает желчи и липазы, мышечные волокна — не хватает кислоты и протеаз, крахмал — амилазы. Это ответ на вопрос «сколько белка он реально усваивает» без всякого подсчёта граммов
УЗИ органов брюшной полости	Застой желчи и состояние поджелудочной сейчас предполагаются, а не подтверждены. От УЗИ зависит, можно ли вообще давать желчегонные — при камнях они опасны
Гастропанель: пепсиноген I и II, гастрин-17, антитела к H. pylori	Объективно подтвердит или опровергнет сниженную кислотность и покажет атрофию. Без этого работа с кислотностью идёт вслепую
Панкреатическая эластаза кала	Функция поджелудочной. Покажет, нужна ли ферментная поддержка — назначает врач
Альбумин + общий белок в динамике	Замена подсчёту белка. Общий белок 80,9 сейчас хороший. Если пойдёт вниз или альбумин упадёт ниже 35 — объём белка возвращаем
HbA1c	Глюкоза 6,78 — это один замер. HbA1c покажет средний сахар за 3 месяца. От этого зависит жёсткость по крупам
Липидограмма	Кальциноз клапанов и гипертрофия МЖП без липидограммы ведутся вслепую. Влияет на количество желтков в рационе
25(ОН)D	D3 назначен вслепую 2000 МЕ. По анализу доза либо вырастет до 4000-5000, либо снизится. Дефицит D — это ещё и мышечная слабость
Ферритин + ОЖСС + железо	MCV 87,4 на нижнем краю — ранний дефицит железа до анемии. Перед эндопротезированием критично: операция даёт кровопотерю
Витамин B12 и гомоцистеин	При сниженной кислотности B12 перестает всасываться. MCV 87,4 сейчас на нижнем краю, то есть картина пока железодефицитная, но кислотность подтачивает и B12
ТТГ (при отклонении — Т4 св.)	Брадикардия 56. Гипотиреоз даёт и брадикардию, и рост ЛПНП, и слабость мышц, и запор — то есть половину картины
Калий, магний, кальций ионизированный	Предсердная экстрасистолия. Дефицит калия и магния — обратимая причина аритмии. Нужен ДО того, как магний пойдёт курсом
СРБ высокочувствительный	Снижение фонового воспаления — одна из задач плана. Без исходной цифры результат измерить нечем
Мочевая кислота и глюкоза натощак — повтор через 6 недель	Контроль, работает ли план. Мочевая кислота 418 при потолке 416,5 — цель уйти к 350 и ниже

18. КРАСНЫЕ ФЛАГИ — когда немедленно к врачу

Симптом	Что делать
Давящая или жгущая боль за грудиной, отдаёт в челюсть, руку, спину	СКОРАЯ, 103. Не ждать, не пробовать пережить
Обморок или предобморочное состояние, потемнение в глазах с перебоями	СКОРАЯ. При брадикардии 56 и паузах RR это возможная блокада
Пульс ниже 45 или ощутимые паузы в сердцебиении	СКОРАЯ или немедленно кардиолог
Перебои в сердце дольше 30 минут подряд, впервые	Кардиолог в этот же день. Возможен срыв в фибрилляцию предсердий

Симптом	Что делать
Одышка в покое или ночью лёжа, нарастающие отёки голеней	Кардиолог срочно — признаки сердечной недостаточности
Рвота с кровью или «кофейной гущей», чёрный дёгтеобразный стул	СКОРАЯ. Желудочно-кишечное кровотечение
Пища застревает, глотать становится труднее	Гастроэнтеролог срочно, повторная ЭГДС с биопсией
Опоясывающая боль в животе с отдачей в спину, с рвотой	СКОРАЯ. Возможен панкреатит
Боль в правом подреберье приступом, тошнота, желтизна кожи или глаз	СКОРАЯ. Возможна желчная колика — ещё одна причина сделать УЗИ заранее
Внезапная сильная боль в суставе, покраснение, отёк, кожа горячая	Ревматолог срочно — похоже на подагрическую атаку. Сдать мочевую кислоту
Потеря веса больше 5% за месяц без усилий	Терапевт, онкопоиск. На этом плане вес так падать не должен
Нога перестала держать, сустав заклинило, резкая деформация	Травматолог-ортопед, не откладывая
Изжога усилилась после старта плана	Уменьшить объём порции и жир, всё протереть. Не ушло за 5 дней — гастроэнтеролог

19. С ЧЕГО НАЧАТЬ

Шаг	Что сделать	Когда
1	Записаться к кардиологу и сделать холтер. До заключения — никаких нагрузок и никаких разгрузочных дней	На этой неделе
2	Сдать копрограмму и сделать УЗИ органов брюшной полости. Это два анализа, которые меняют план больше всего	На этой неделе
3	Убрать из дома всё из раздела 13. Начать с четырёх: алкоголь, сахар, кофе, всё сырое и жареное	Сегодня
4	Купить пароварку или мультиварку, если её нет. Без неё этот план не выполнить	1-2 дня
5	Первая неделя — только два приёма и мягкая еда. Добавки пока только псиллиум 3 г и цинк-карнозин	Дни 1-7
6	Со второй недели добавлять по одной позиции раз в 3-4 дня: глутамин, потом D3 с K2, потом магний, потом остальное	С 8-го дня
7	Дневник в три строчки: стул, вздутие, тяжесть после еды. Больше не нужно	Каждый день
8	Остальные анализы из раздела 17 — по мере возможности, не всё сразу	2-3 недели
9	Пересдать мочевую кислоту, глюкозу, альбумин и общий белок. Сравнить с апрелем	Через 6-8 недель

Важно. Документ носит нутрициологический характер: питание, режим, нутриенты. Он не является медицинским назначением, не заменяет консультацию врача и не содержит назначения лекарственных препаратов. Диагнозы не устанавливаются. Сниженная кислотность и застой желчи приняты со слов специалиста и подлежат подтверждению гастропанелью и УЗИ. При коксартрозе 4 ст. хрящ отсутствует и восстановлению питанием не подлежит — задача плана в другом: восстановить работу ЖКТ, снизить фоновое воспаление и подготовить организм к операции. План вторичен по отношению к заключению кардиолога по холтеру.